

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	消化性潰瘍 Peptic Ulcer				
編號	A31000-Q03-W-D01	制定者	N16 蔡富卿	公布日期	97 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 3.9 版/12 頁	審查者	曾翊鍵	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解消化性潰瘍的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

消化性潰瘍是指消化道的黏膜層、肌肉層，因受到外來刺激或胃酸分泌過多，破壞消化道黏膜層及碳酸中和屏障，進一步影響消化道上皮細胞癒合能力形成潰瘍。消化性潰瘍又可以分為十二指腸潰瘍及胃潰瘍兩種：十二指腸潰瘍常以年輕人為主，胃潰瘍則以 50 歲以上年紀較大者為主。常見病因有：幽門螺旋桿菌感染、長期服用水酸類藥物（例如：Aspirin）、類固醇、非類固醇類消炎止痛 (Nonsteroidal anti-inflammatory drug, NSAIDs) 藥物。此疾病再發率高，除非經特殊治療（例如：根除幽門螺旋桿菌治療），否則不易治癒。

（二）症狀

1. 上腹痛：十二指腸潰瘍疼痛常出現在攝食後 2~3 小時；胃潰瘍疼痛常出現在攝食前 30 分鐘~1 小時。十二指腸潰瘍的典型症狀是在右上腹、臍上方出現疼痛或燒灼感，夜間發作機率較胃潰瘍高，可透過進食鹼性食物（例如：牛奶、蘋果）緩解；胃潰瘍的典型症狀是在上腹部或左腹中線地區出現燒灼或痙攣性

主題名稱	消化性潰瘍	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D01	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	2/12

疼痛，其餘症狀包括食慾不振、腹脹、噁心、嘔吐，愈吃東西越痛。

2. 上消化道出血：十二指腸病人常出現解黑便，胃潰瘍病人常出現嘔血。

(三) 常見檢查

1. 理學檢查：若出現因潰瘍導致的穿孔，在觸診腹部時會出現壓痛及反彈性疼痛。
2. 上消化道內視鏡檢查(Panendoscopy)：探查消化道潰瘍情形，若為惡性潰瘍可以看見在病灶周圍出現不規則增厚及出血。
3. 上消化道鋇劑攝影：讓病人吞食鋇劑，在透過放射線攝影觀察胃皺壁及腸壁黏膜完整度。
4. 胃液分析：檢查胃液量（十二指腸潰瘍常出現胃液量過多）、游離酸量、pH 值、幽門螺旋桿菌培養。
5. 糞便潛血檢查：若消化性潰瘍合併上消化道出血，則會出現陽性反應。
6. 全血球計數：可能出現貧血徵象，血比容(Hct)、血色素(Hb)下降
7. 檢驗幽門螺旋桿菌(H.pylori)：血清學檢驗（90%敏感度，70-80%特異性，治療若有效，價度會在 3-4 個月下降）；尿素呼氣檢驗（簡稱 UBT，敏感性和特異性都超過 95%）；胃鏡加上快速尿素酶檢驗（例如 CLO fest 碳 13 呼氣試驗，敏感性和特異性都超過 95%）或切片和組織學診斷。
8. 胸部 X 光檢查：百分之六十以上的病人在穿孔後六小時可以在直立的胸部 X 光片看到橫膈膜下有異常氣體，憑此即可診斷有消化道的穿孔，對於無外傷的人，原因幾乎都是因為消化性潰瘍穿孔。

(四) 常見治療

1. 藥物治療：藥物治療的機轉主要在於減少胃酸分泌、加強黏膜保護、除去幽門螺旋桿菌常用藥物可分成六類：

(1) 組織胺第二型接受體拮抗劑 H₂ Blocker：例效果好，耐受力高且相當安全。

服用八週後，胃潰瘍有近九成之癒合率，十二指腸則達九成以上。唯經肝

主題名稱	消化性潰瘍	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D01	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	3/12

腎代謝，故有嚴重的腎機能障礙者應減量。常見藥物如：Cimetidine、Ranitidine、Nizatidine、Famotidine。

- (2) 質子幫浦抑制劑(Proton pump inhibitor, PPI)：抑制胃壁細胞膜上 H-K ATPase，降低胃酸分泌，效果顯著，解除疼痛的效果比 H₂ Blocker 來得快。常見藥物如：Omeprazole(Losec)、Pantoprazole(Pantoloc)、Esomeprazole(Nexium)。
- (3) 黏膜屏障防禦製劑：Sucrafate，為硫酸鹽多糖類，可與氫氧化鋁結合後選擇性地與潰瘍處結合，達到保護胃壁，促進組織新生修復，對抽煙者的預防潰瘍復發有特別好處。
- (4) 前列腺素合成劑：Misoprostol(Cytotec)，為前列腺素 E1 的相似物，抑制胃壁細胞組織胺接受器，減少胃酸分泌，用以預防 NSAID 引起的胃潰瘍，副作用是拉肚子。此藥台灣還不普遍。
- (5) 制酸劑 Antacid：主要成分為氫氧化鋁、氫氧化鎂或碳酸鹽類，飯後 1 小時服用效果最好，用以直接中和胃酸，防止胃酸侵蝕。氫氧化鎂易引起腹瀉，而氫氧化鋁則會導致便秘。腎衰竭病人使用這些制酸劑應小心，切勿加重其電解質不平衡。常見藥物如：Magnesium Hydroxide、Aluminum Hydroxide、Maalox。
- (6) 鉍化合物(Bismuth Compounds)：可在胃酸環境與醣蛋白結合，產生複合物附著在潰瘍部位，達到保護作用。
- (7) 幽門螺旋桿菌的去除，鉍鹽(Bismuth)加上抗生素可除去此菌，減少潰瘍復發機會。

2. 外科治療

- (1) 單純性縫合(Simple Closure)：用於年紀大狀況不佳的潰瘍穿孔病人。
- (2) 迷走神經幹切除術及胃竇切除術(Truncal Vagotomy and Antrectomy)：常用在合併穿孔及腸阻塞病人，將病灶切除後，再將迷走神經幹切斷，減少胃酸分泌。

主題名稱	消化性潰瘍	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D01	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	4/12

3. 非藥物治療：非藥物治療的配合與服藥同等重要，菸酒或其他引起疼痛的食物應避免，而阿斯匹靈或 NSAID，甚至類固醇，除非醫師處方，有潰瘍的病人最好不要再服用這些藥物。生活習慣之守則如下：定時定量、細嚼慢嚥、少量多餐（可在上、下午、睡前增加一次點心）、飯後略作休息後再開始工作、心情愉快、蛋白質要豐富並採溫和飲食（不純吃澱粉含量高的食物，均衡攝取六大類食物）。

4. 內視鏡治療：內視鏡治療潰瘍出血是目前醫院首用的治療方式，成功率高合併症少，目前常用的治療方式有四種：

(1) 注射法：這項治療最早被採用且使用最廣泛的治療，常見的是注射稀釋的腎上腺素(1：1000)，其他的注射液還包含純酒精、高張鹽水、高張葡萄糖水。注射方式是藉溶液壓力或溶液促進血管收縮，造成血栓達到止血效果。

(2) 止血夾：對組織的傷害小而且再出血率低是一個理想工具，但若是慢性潰瘍因基底部已經纖維化，因此不容易使用止血夾夾住。

(3) 電燒法。

(4) 手術。

（五）護理問題

1. 疼痛不適／胃黏膜受損有關。

2. 缺乏營養／禁食。

3. 健康保護能力不足／缺乏相關資訊有關。

4. 易體液容積不足／和有效血流量減少有關。

5. 易受傷害／與合併症有關。

（六）護理措施

1. 疼痛不適／胃黏膜受損有關

(1) 注意觀察生命徵象。

(2) 避免劇烈的身體活動，以降低胃分泌及蠕動。

主題名稱	消化性潰瘍	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D01	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	5/12

- (3) 鼓勵多休息，並安排適於休息的環境，減少干擾休息因素來促進復原。
- (4) 評估疼痛部位、特性、時間、頻率、性質、強度或嚴重度。
- (5) 觀察病人不舒適的非語言暗示，特別是那些無法有效地溝通之病人。
- (6) 確認病人有接受適當之止痛照護。
- (7) 提供病人及家屬尋求及提供支持。
- (8) 選擇疼痛緩解措施時，須考慮疼痛的型態及位置。
- (9) 依醫囑給予適合之止痛藥，緩解疼痛。
- (10) 評估病人的疼痛經驗，以評值疼痛控制措施的成效。
- (11) 鼓勵家屬陪伴及參與。
- (12) 評估止痛藥之效果及有無副作用。
- (13) 採舒適臥姿，減輕疼痛。
- (14) 轉移其注意力，如聊天、聽音樂。

2. 缺乏營養／禁食

- (1) 急性期暫禁食，給予足夠之液體補充。
- (2) 給予飲食衛教，如少量多餐、採溫和飲食、細嚼慢嚥等。
- (3) 評估病人進食量及類別。
- (4) 若有厭食或噁心嘔吐的情形嚴重，可建議醫師給予止吐劑或制酸劑來減輕症狀引起的不適。
- (5) 採坐姿或半坐姿進食並給予充分時間進食、勿催促，必要時協助進食。
- (6) 教導進食前給予口腔護理以增加味覺。
- (7) 建議清淡飲食，避免辛辣、刺激性食物。

3. 健康保護能力不足／缺乏相關資訊有關

- (1) 了解潰瘍的病因和疼痛的含意。
- (2) 了解當刺激作用除去時，便能癒合得很快。
- (3) 了解哪些因素會引發潰瘍的形成，以及必須如何減少刺激。
- (4) 教導減輕壓力的方法（放鬆技巧、音樂治療、休閒運動）正常睡眠時間，

主題名稱	消化性潰瘍	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D01	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	6/12

降低胃酸分泌。

(5) 找出會刺激胃酸分泌而引起疼痛的物質，並自食物中去除這些物質，直到潰瘍癒合。

(6) 了解維持性治療停止，潰瘍的復發率超過 50%。

(7) 若為幽門桿菌感染所致，須搭配抗生素服用一段時間，勿自行停藥。

(8) 了解戒菸、酒及規律飲食習慣的重要性。

(9) 避免服用水楊酸類（例如：Aspirin）及 NSAID 的藥物，預防出血。

(10) 給予飲食衛教，了解何種食物不適合吃。

(11) 教導病人了解自己所服藥物的作用及副作用，及服用方式，並強調確實及定時服藥的重要性。

4. 易體液容積不足／和有效血流量減少有關。

(1) 監測生命徵象、意識狀態及有無休克症狀。

(2) 評估皮膚的溫度及顏色。

(3) 觀察、記錄出血量及出血情形，並告知醫師。

(4) 絕對臥床休息，避免暈眩造成意外。

(5) 鼓勵家屬陪伴，給予心理支持。

(6) 依醫囑予補充液體或血液，並記錄輸出入量。

5. 易受傷害／與合併症有關

(1) 監測生命徵象以評估是否有休克的症狀。

(2) 監測潰瘍合併症形成，如評估腹部是否有疼痛、一觸即痛，或僵直的情形。

(3) 若懷疑有穿孔，應立即告知醫師。

(4) 如有嘔吐，應記錄其頻率，及嘔吐物的性狀。

(5) 暫時禁食，給予液體補充。

(6) 如有腹脹，評估是否以鼻胃管來改善不適，並記錄量、性質及顏色與病人及健康照護小組共同評估病人過去曾使用過之有效的疼痛控制措施。

主題名稱	消化性潰瘍	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D01	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	7/12

- (7) 鼓勵家屬陪伴，有任何不適，應立即通知醫護人員。
- (8) 教導病人自我評估合併症的發生與徵象（解血便、皮膚濕冷、心搏過速、劇烈疼痛、腹脹、噁心、嘔吐）
- (9) 增加探視次數。

（七）衛教指導

1. 上腸胃道出血的預防方法

- (1) 營養要均衡，多吃高營養、高蛋白的食物。
 - (2) 採取少量多餐的飲食習慣。
 - (3) 避免暴飲暴食。
 - (4) 吃飯要定時，上班、上學的人最好早起，從容的吃早餐。
 - (5) 少吃刺激胃酸分泌增加的食品，如太辣、太鹹、太酸的食物，可樂、汽水、茶等。
 - (6) 進食時需充分咀嚼，緩慢進食，飯後應有短時間的休息。
 - (7) 避免抽煙、喝酒、喝咖啡。
 - (8) 每天應有一定的休息時間、睡眠、避免熬夜。
 - (9) 每天應有適當的休閒娛樂，以放鬆緊張心情。
 - (10) 避免高壓力的工作或工作過度勞累。
 - (11) 不要亂服用止痛劑、類固醇及水楊酸類（例如：Aspirin）的藥物。
 - (12) 經常做抒解壓力的運動：
 - A. 找一個舒適不受干擾的環境。
 - B. 用力收縮肌肉並維持肌肉收縮狀態 5-7 秒。
 - C. 迅速而完全放鬆肌肉、精神也應同時放鬆。
 - D. 每一部份肌肉應同時收縮、一起放鬆。
 - E. 依下列順序收縮、鬆弛肌肉。
- 左（右）手前臂→左（右）二頭肌→左（右）手和前臂→左（右）二頭

主題名稱	消化性潰瘍	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D01	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	8/12

肌→前額→眼睛→嘴巴和下額→喉和頸部→背部→胸部→胃部→臀部→
大腿→小腿。

(13) 瞭解出血復發之徵象：

吐血、解黑便、昏厥、口渴、恐懼坐立不安、呼吸困難等，若有復發的情形應儘早就醫，定期接受檢查可防止再復發的機會。

2. 消化性潰瘍之飲食衛教

(1) 飲食原則

- A. 細嚼慢嚥，進餐時保持心情愉悅，飯後先休息會再工作。
- B. 定時定量，規律飲食習慣。
- C. 少量多餐，避免吃飯時喝湯。
- D. 飲食應含有足夠的營養且無刺激性。
- E. 生活要有秩序，不要熬夜，放鬆心情，不過分緊張及焦慮。
- F. 戒菸、酒，在服用潰瘍藥物治療才可飲用牛奶。

(2) 飲食選擇依病情程度分為三期

- A. 溫和飲食第一期：自出血始至血止 2-3 天；應先禁食 1-2 天，使胃有足夠的休息，但可喝水，以防止口渴，然後逐漸給於不加糖的冷牛奶或無糖冷豆漿（非冰的），或將食物製成流質狀供應。
- B. 溫和飲食第二期：於止血後 2~3 天至恢復期；與軟質飲食大致相仿，忌食刺激性食物，如：肉湯、甜點、太甜水果、含纖維多的蔬菜、含筋及過老的肉類、及刺激性的調味品和飲料，多食含蛋白質、鐵質豐富的食物。
- C. 溫和飲食第三期：恢復期；與普通飲食相仿，除非病人感覺不適，但咖啡、酒、濃茶、乾果類、刺激性的調味品及未成熟之水果需避免。

3. 日常生活中飲食該如何保養

- (1) 生活規律常保持愉快的心情。
- (2) 充足的睡眠可促進潰瘍癒合，且避免再發。

主題名稱	消化性潰瘍	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D01	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	9/12

(3)避免應酬，戒煙、戒酒。

(4)養成良好的飲食習慣。三餐定時定量，細嚼慢嚥如牙齒不好，要儘快治療。

(5)進餐時宜安排足夠時間，進食前後需休息 30 分，及在輕鬆的氣氛下進食。

(6)少量多餐，避免吃飯時喝湯、冷熱交替進食及吃生食。

(7)天氣轉涼會使自律神經失調，胃酸大量分泌，故易復發，需隨時保暖，注意天氣變化。

(8)消化性潰瘍復發率高，不可以因症狀消失就不吃藥，須按照醫師指示服藥。

(9)不亂服成藥。一般而言：感冒藥、鎮定劑等都會傷胃，最好於飯後或與胃藥一起服用。

(10)消化性潰瘍在科學發達的今天，仍是無法根治的疾病。最好的藥物只是加速潰瘍癒合和減少復發機會。所以潰瘍患者一定要嚴格遵守醫護人員指示好好治療！

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 李薇莉、周繡玲(2020).消化系統疾病護理·於劉雪娥總校閱，內外科護理學下冊
(八版，368-375 頁)·台北市：華杏。

主題名稱	消化性潰瘍	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D01	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	10/12

(二) 趙圓平、徐邦焱、王家麒 (2021)。消化性潰瘍的介紹及診斷。家庭醫學與基層醫療，36(2)，60-66。 [https://www-airitilibrary-com.sw.lib.csmu.edu.tw:8443/Article/Detail?DocID=P20090727001-202102-202103020017-202103020017-60-66](https://www.airitilibrary-com.sw.lib.csmu.edu.tw:8443/Article/Detail?DocID=P20090727001-202102-202103020017-202103020017-60-66)

七、附件

(略)

八、文件修正紀錄

主題名稱	消化性潰瘍	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D01	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	11/12

修正日期	版本	修正說明	備註
97.05.31	1.0	新制定	97 年 05 月 31 日護理部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
100.08.31	2.1	(1)修改說明內容錯字 (2)病人改病人	100 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
101.08.31	2.2	醫護部改護理部	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.08.31	3.1	護理問題及措施刪除：潛在危險性傷害／出血 修改為：體液容積缺失：出血和有效血流量減少有關等內容	103 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
104.08.31	3.2	更新第六項參考資料	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	3.3	1. 新增參考文獻出處於內文中。 2. 更新第六項參考文獻資料。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.08.31	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.4	第二項新增（含中興分院）。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過
108.09.23	3.5	1. 第三項第四目之 1(2)新增主題英文(Proton pump inhibitor, PPI)。 2. 第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過;108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。

主題名稱	消化性潰瘍	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D01	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	12/12

修正日期	版本	修正說明	備註
109.08.18	3.6	第六項參考資料修訂。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過； 109 年 08 月 12 日護理長會議通過；109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。
110.08.05	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.09.06	3.7	1. 更新第三項第一、二、三、四目說明內容文字修訂。 2. 更新第三項第五、六目護理問題。 3. 修訂第六項參考文獻資料。 4. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過； 111 年 08 月 10 日護理長會議通過；111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。
112.08.03	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.09.03	3.8	刪除第六項參考資料年限較久參考文獻。	113 年 08 月 08 日照護標準組會議通過； 113 年 08 月 14 日護理長會議通過；113 年 09 月 03 日督導會議通過公布。
114.10.08	3.9	修訂第六項參考文獻資料。	114 年 08 月 07 日照護標準組會議通過； 114 年 09 月 10 日護理長會議通過；114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。